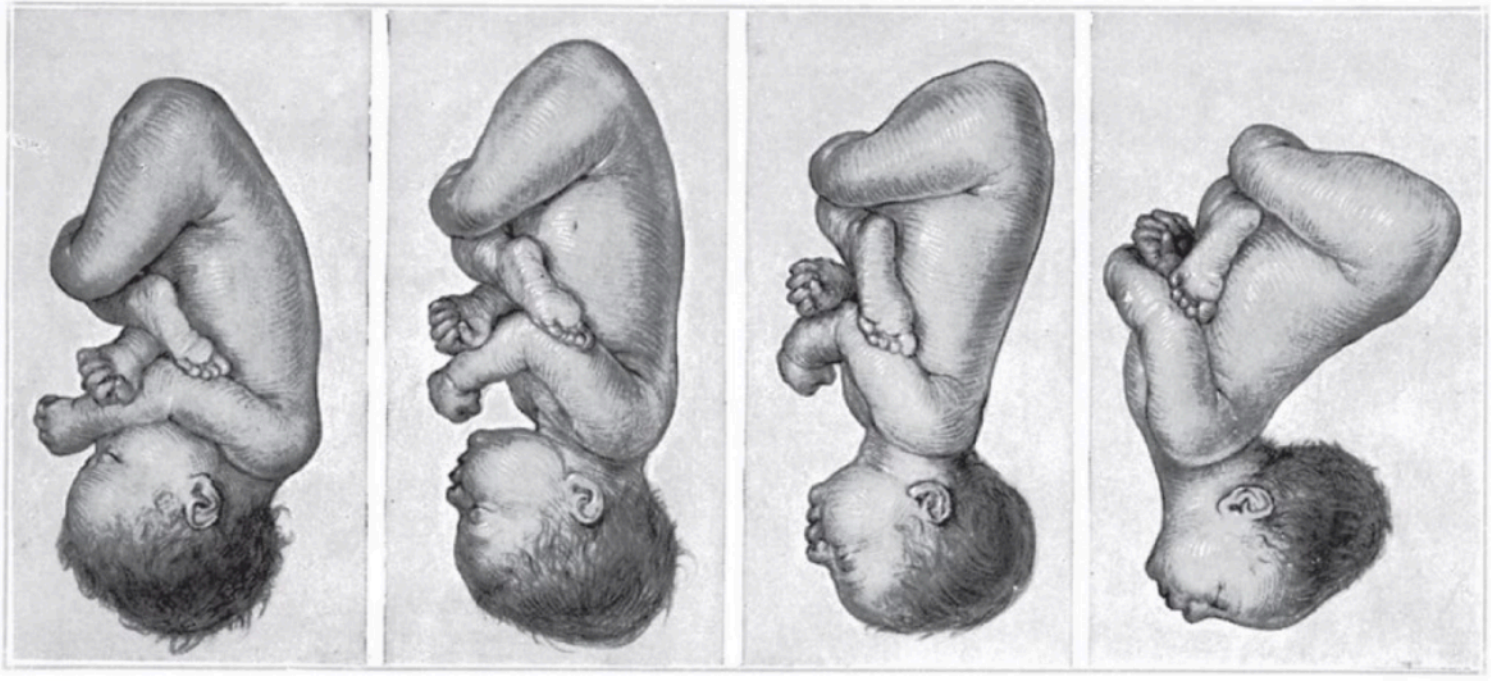
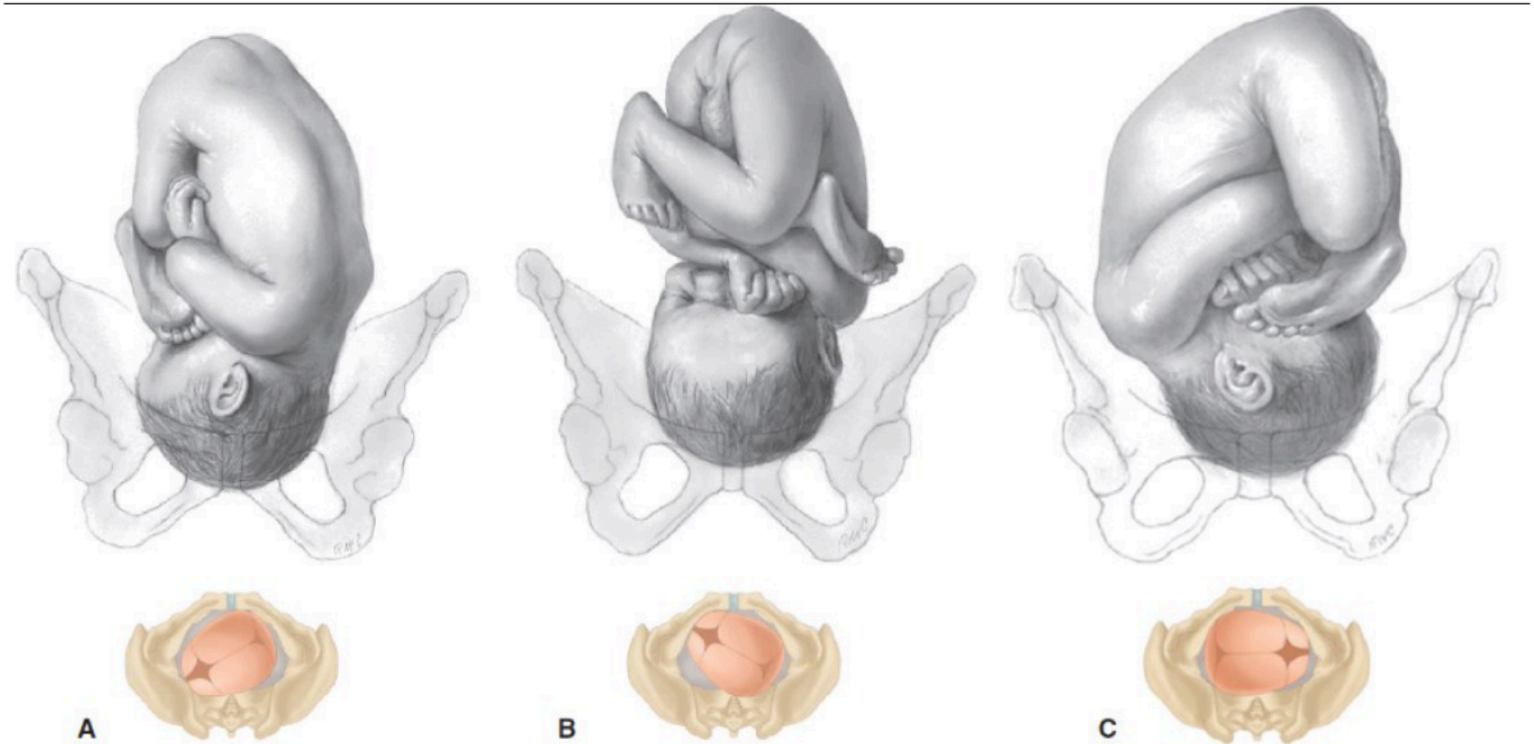


Fuente: F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong: Williams Obstetricia, 26e
Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.



Fuente: F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong: Williams Obstetricia, 26e
Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Documento de origen: CAPÍTULO 22_ Trabajo de parto normal-2.pdf

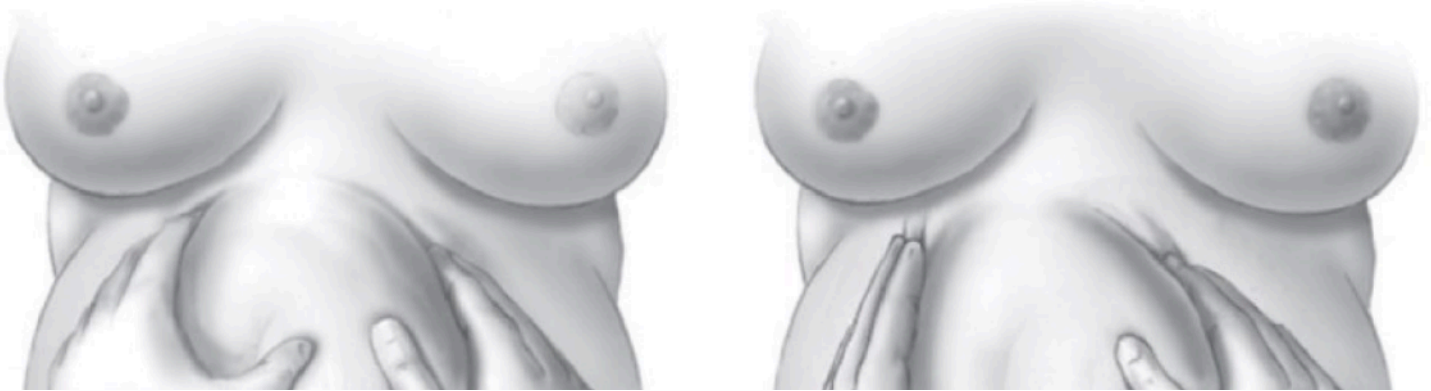


Imagen 3/23: CAPÍTULO_22__Trabajo_de_parto_normal-2.pdf-0004-10.png

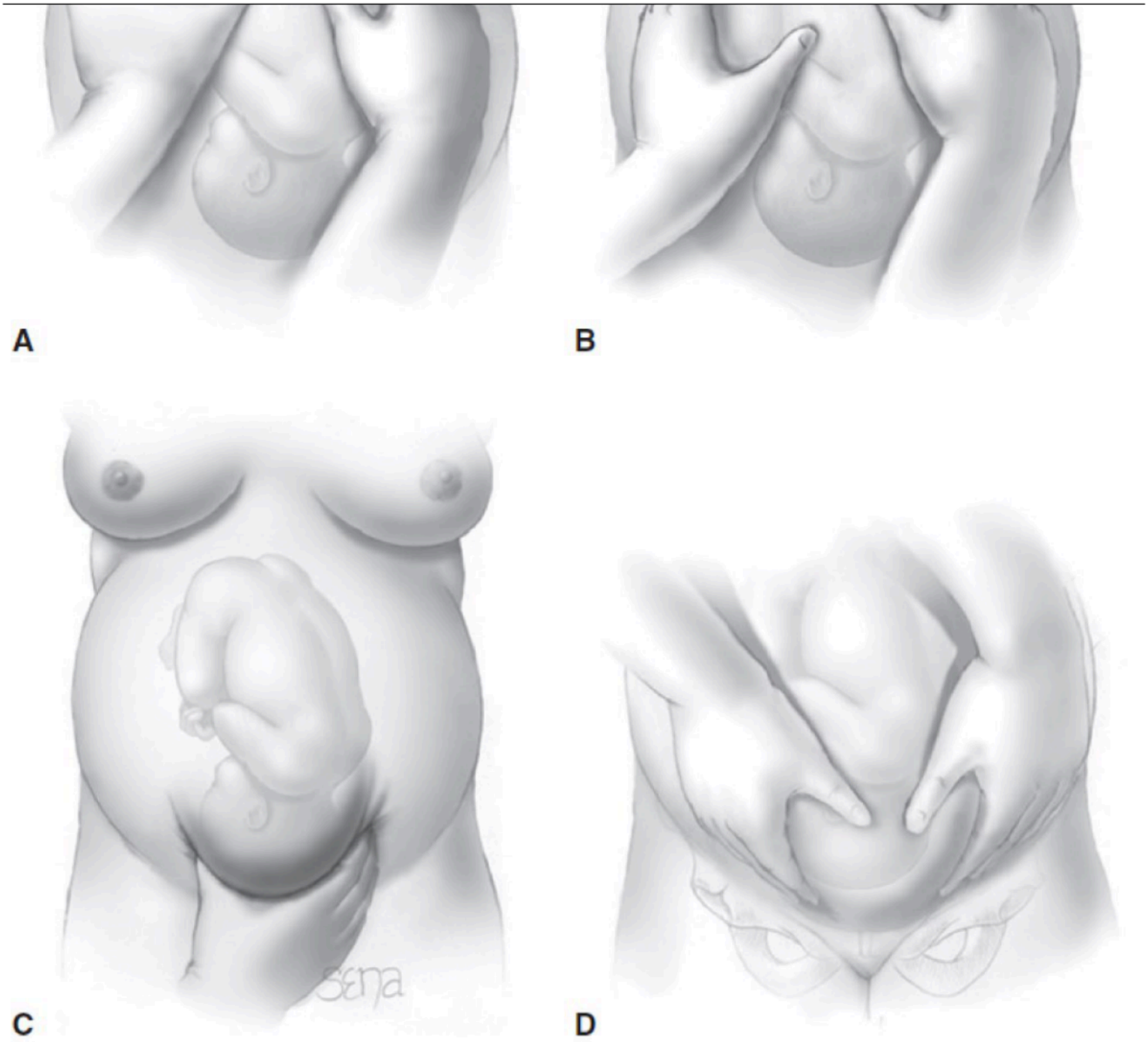
Documento de origen: CAPÍTULO 22_ Trabajo de parto normal-2.pdf

ACCESS Medicina™

UNAN - Leon

Access Provided by:

SILVERCHAIR



Fuente: F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong: Williams Obstetricia, 26e
Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

Imagen 4/23: CAPÍTULO_22__Trabajo_de_parto_normal-2.pdf-0005-03.png

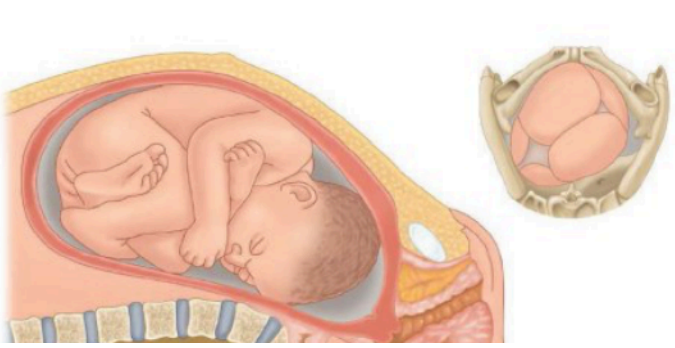




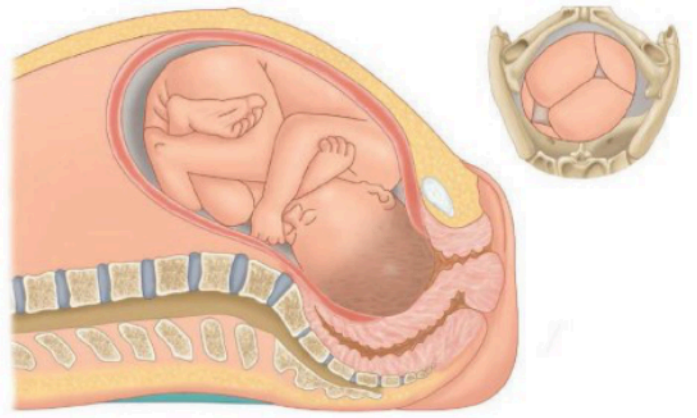
Imagen 5/23: CAPÍTULO_22__Trabajo_de_parto_normal-2.pdf-0006-16.png

ACCESS Medicina™

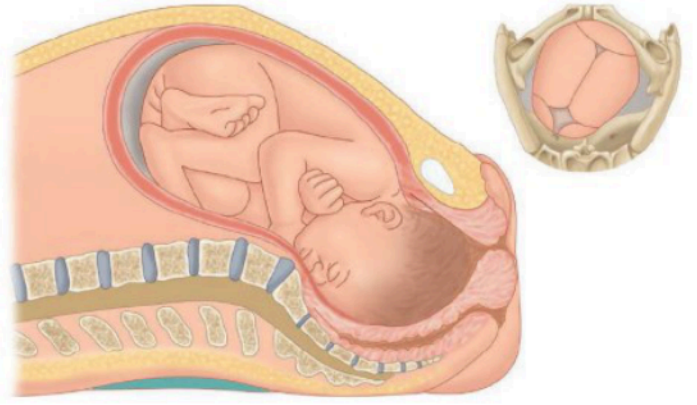
UNAN - Leon
Access Provided by:
SILVERCHAIR



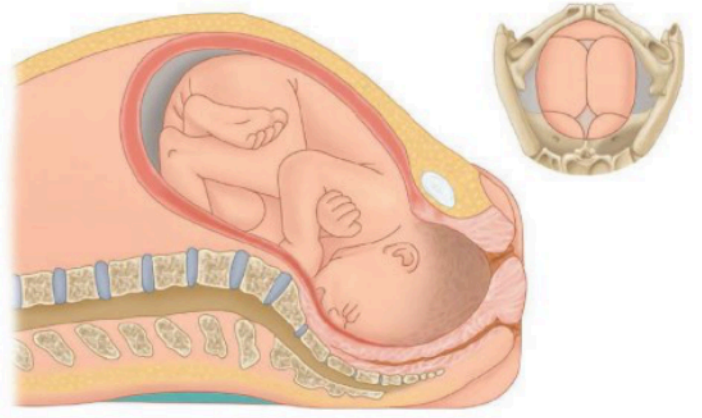
1. Cabeza flotante, antes del encajamiento



2. Encajamiento, descenso, flexión



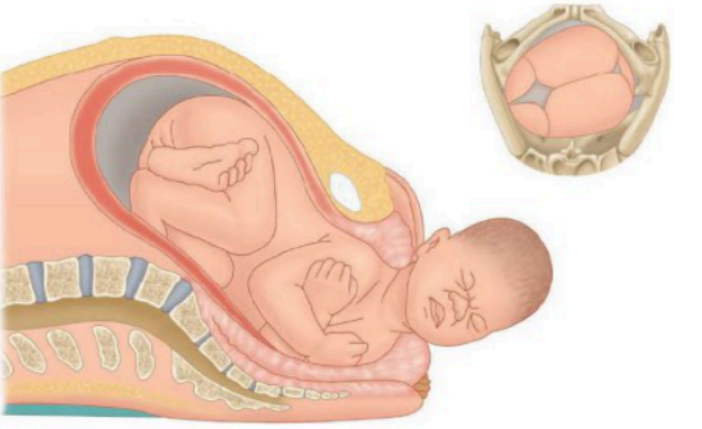
3. Descenso adicional, rotación interna



4. Rotación completa, inicio de la extensión



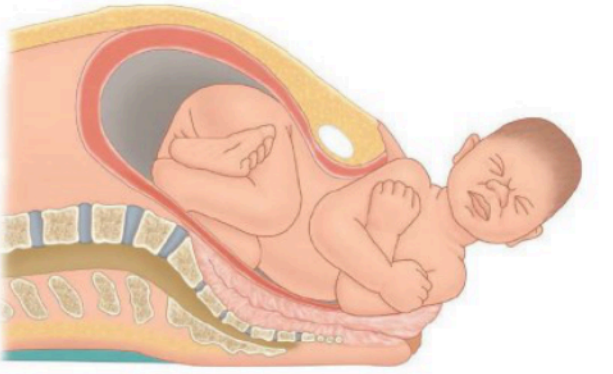
5. Extensión completa



6. Restitución (rotación externa)



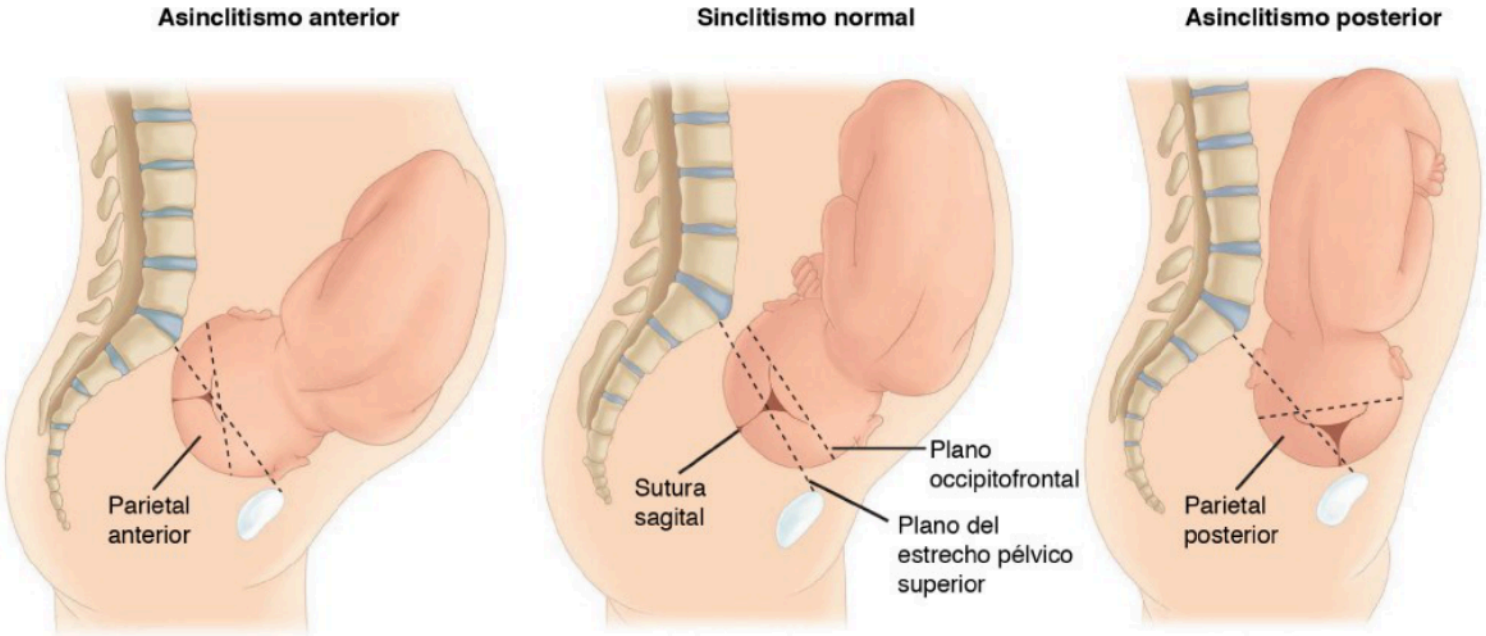
7. Nacimiento del hombro anterior



8. Nacimiento del hombro posterior

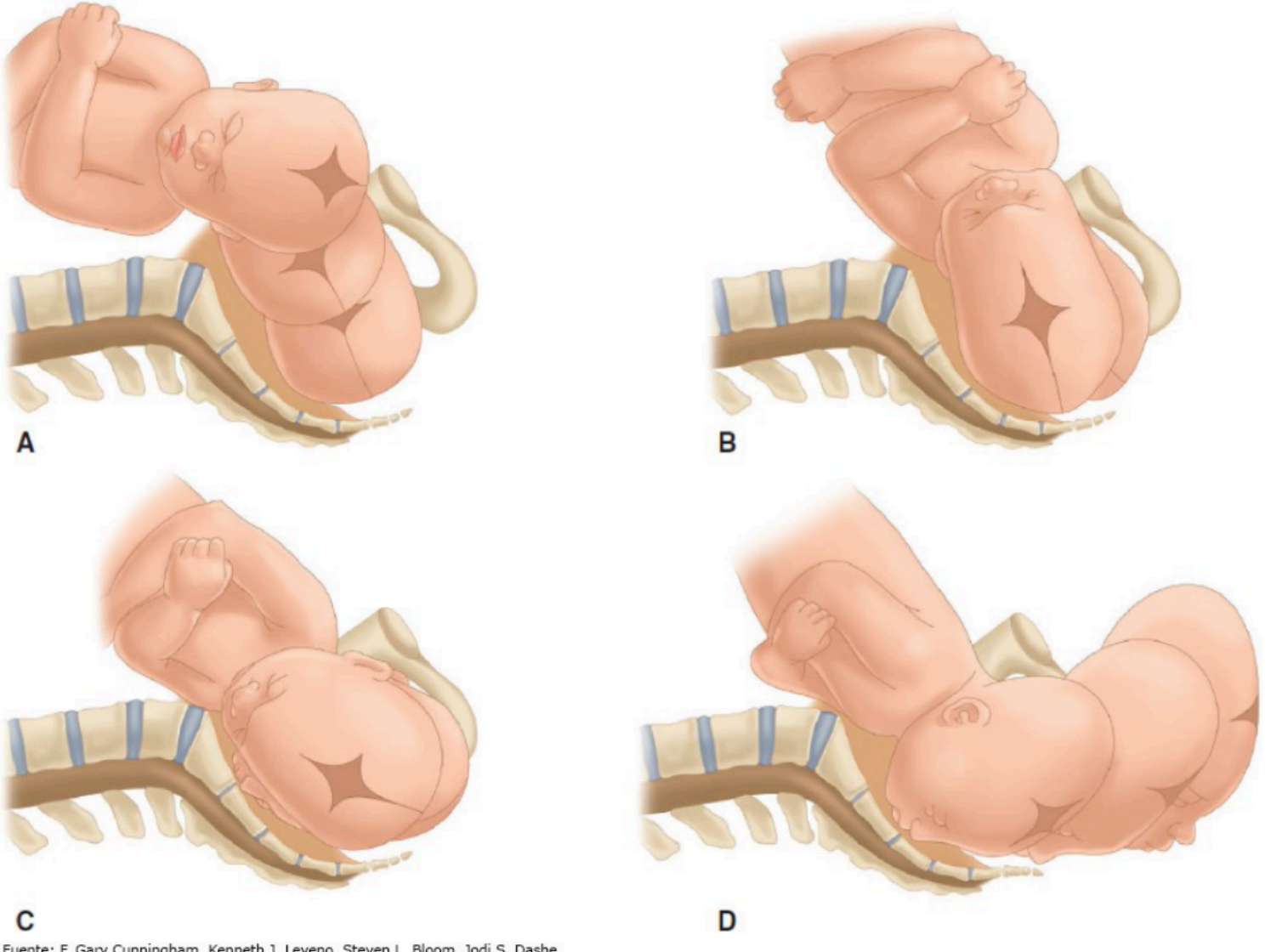
Downloaded 2023-2-16 2:18 A Your IP is 187.228.203.135

Documento de origen: CAPÍTULO 22_ Trabajo de parto normal-2.pdf

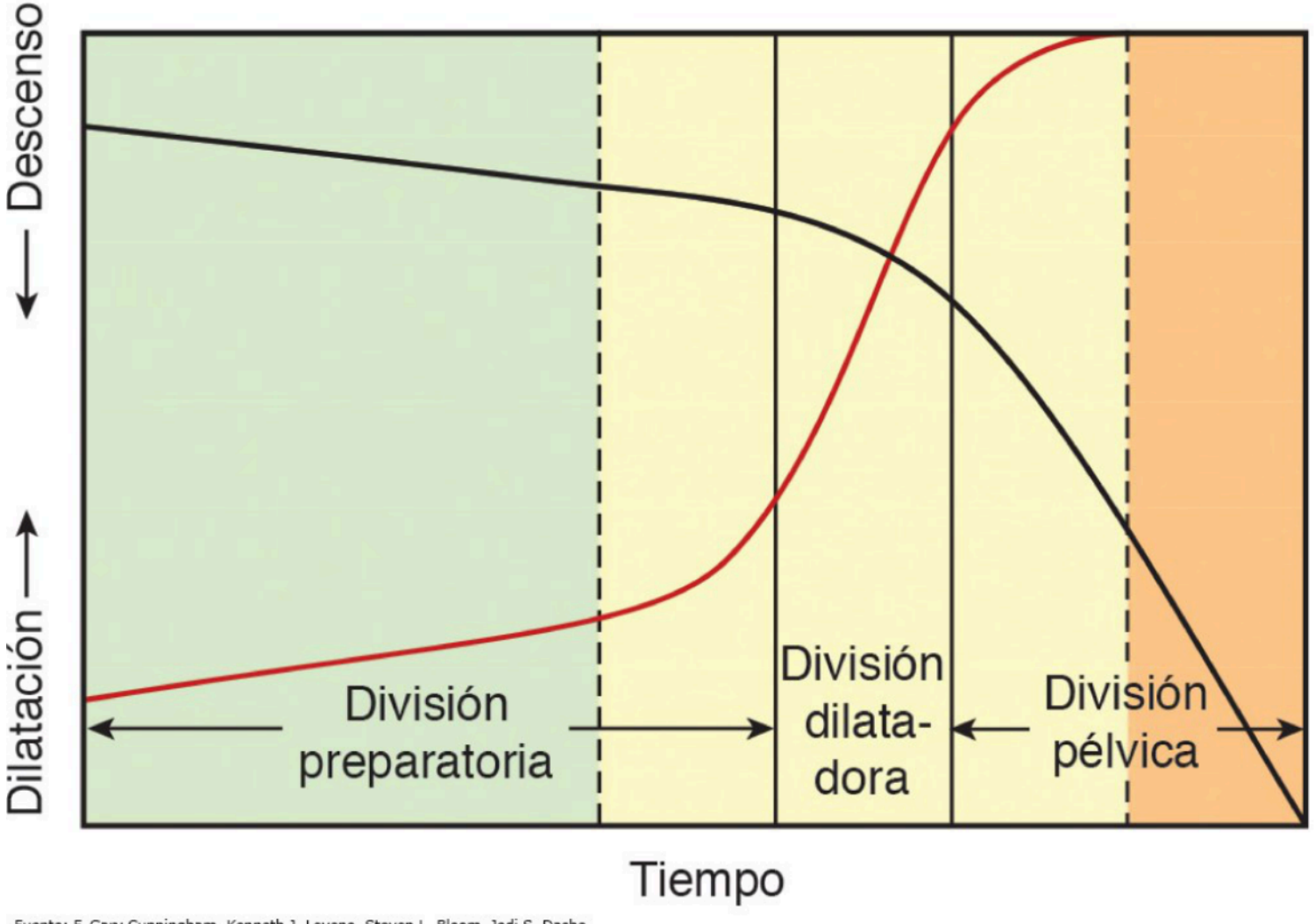


Fuente: F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong: Williams Obstetricia, 26e
Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

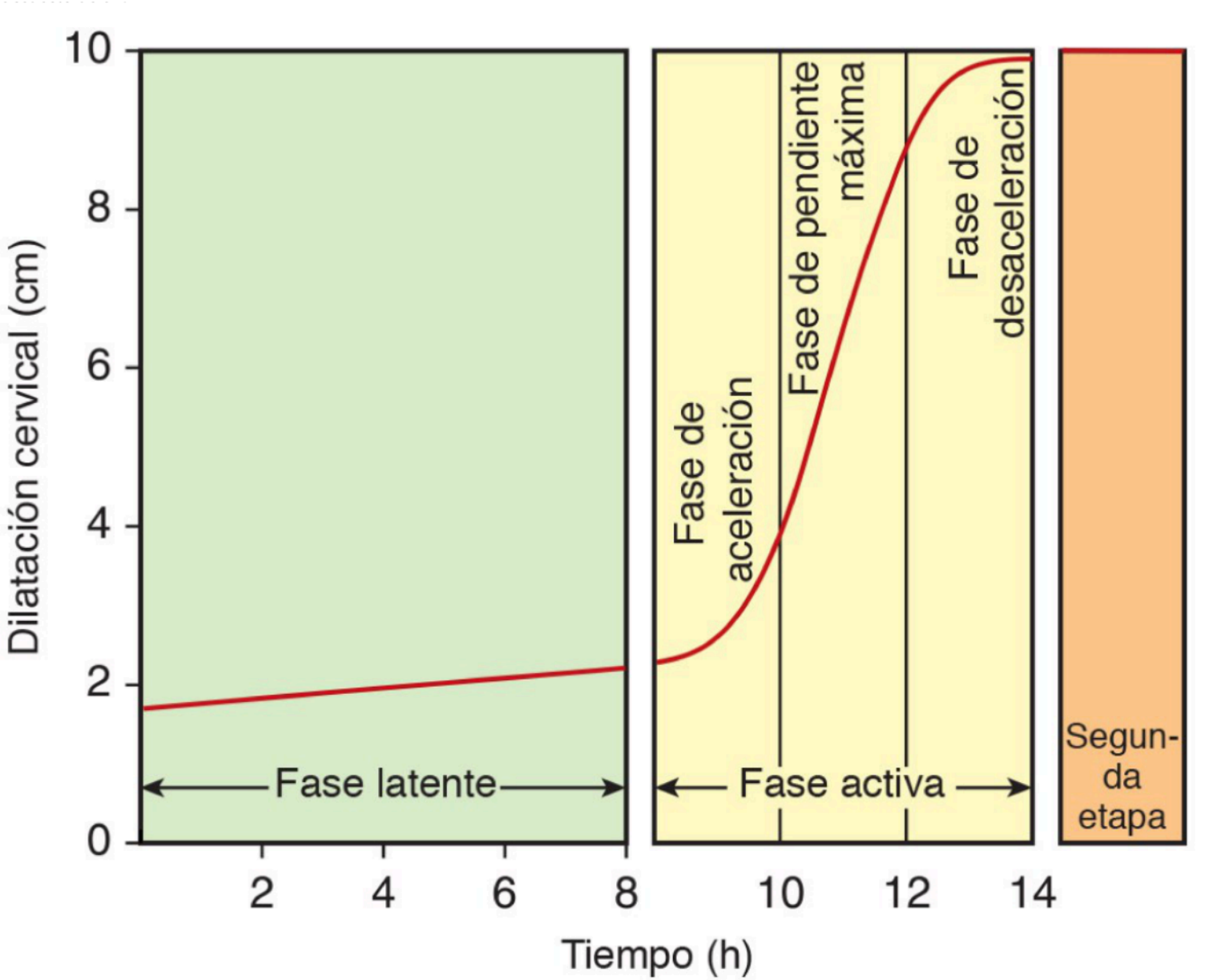
Imagen 7/23: CAPÍTULO_22__Trabajo_de_parto_normal-2.pdf-0008-10.png



Fuente: F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong: Williams Obstetricia, 26e
Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.



Fuente: F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong: Williams Obstetricia, 26e
Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.



Fuente: F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong: Williams Obstetricia, 26e
Copyright © McGraw Hill Education. Todos los derechos reservados.

E	Una revisión sistemática Cochrane en la que se incluyeron 27 ECA de distintos países de altos y medianos ingresos (n= 15,858 mujeres en trabajo de parto), comparó el acompañamiento continúo durante el trabajo de parto versus el manejo convencional, para observar su efecto en los desenlaces materno y perinatal, concluyó que el acompañamiento continuo durante el trabajo de parto (definido como el acompañamiento que brinda apoyo emocional, brinda medidas de comfort e información) aumenta la posibilidad de un parto vaginal (RR 1.08, IC95% 1.04 a 1.12, evidencia de baja calidad), disminuye la posibilidad de tener una experiencia negativa durante el parto (RR 0.69 IC95% 0.59 a 0.79, evidencia de baja calidad) y la posibilidad de uso de analgesia epidural (RR 0.90 IC95% 0.84 a 0.96). Además se asoció a menor duración del trabajo de parto (MD -0.69 horas, IC95% -1.04 a -0.34), menor riesgo de cesárea (RR 0.75 IC95% 0.64 a 0.88) y de parto instrumentado (RR 0.90 IC95% 0.85 a 0.96).	1+ NICE *Bohren MA, 2017*
R	Durante la fase activa del trabajo de parto, se recomienda el acompañamiento continuo (por familiar o personal de salud) en mujeres con embarazo no complicado.	A CTFPHC *Lee L, 2016*

Imagen 11/23: gpc_atención_amigable_del_tdp.pdf-0016-05.png

E	Los hallazgos de una revisión sistemática Cochrane en la que se incluyeron tres ECA (6,241 mujeres y 6,241 recién nacidos), pero en el que solamente dos estudios se incluyeron en el meta análisis (3,242 mujeres y 3,242 recién nacidos), concluyó que la auscultación fetal intermitente con monitor fetal electrónico versus Pinard, no mostró diferencias significativas entre los grupos referentes a la calificación de Apgar a los 5 minutos en los recién nacidos (RR 0.66, IC95% 0.24 a 1.83, 633 recién nacidos, evidencia de muy baja calidad), así como tampoco sobre la mortalidad perinatal (RR 0.88, IC95% 0.34 a 2.25; 633 recién nacidos, evidencia de muy baja calidad). Con relación a los desenlaces maternos, no hubo diferencias significativa entre los grupos para la cesárea o el parto instrumental (RR 0,70, IC95%: 0,35 a 1,38 y RR 1,21; IC95%: 0,69 a 2,11, respectivamente, evidencia de baja calidad).	**2+** **NICE** *Martis R, 2017*
R	Se recomienda auscultar intermitentemente la frecuencia cardiaca fetal durante el trabajo de parto de mujeres sanas (cada 15 a 30 minutos), ya sea con Pinard o con monitor fetal Doppler, durante un minuto inmediatamente después de la contracción.	**Recomendado** **GRADE** *National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guidelines. Intrapartum Care, 2014*
R	No se recomienda realizar cardiotocografía continua en mujeres sanas que iniciaron espontáneamente el trabajo de parto.	**No Recomendado** **GRADE** *WHO: intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018*
E	En una revisión sistemática Cochrane en la que se incluyeron 5 ECA con un total de 3,130 mujeres, para determinar los beneficios y los daños entra la ingesta versus la restricción de líquidos y alimentos durante el trabajo de parto, sobre los desenlaces materno y fetal, mostró que no se observaron diferencias estadísticamente significativas con relación a la tasa de cesáreas (RR 0.89 IC95% 0.63 a 1.25), parto instrumentado (RR 0.98 IC95% 0.88 a 1.1) y calificación de Apgar (RR 1.43 IC95% 0.77 a 2.68).	**1+** **NICE** *Singata M, 2013*
R	En mujeres con trabajo de parto no complicado, se recomienda la ingesta de líquidos claros.	**Recomendado** **GRADE** *WHO: intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018* **A** **CTFPHC**

R	Dado que no se encuentra evidencia que apoye o rechace el uso de la exploración vaginal de rutina durante el trabajo de parto, se puede considerar la realización de tacto vaginal cada cuatro horas, durante la fase activa del primer periodo del trabajo de parto.	**Fuerte** **GRADE** *WHO recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections, 2015*
E	En una revisión sistemática Cochrane en la que se incluyeron 15 ECA, con una población de 5,583 mujeres con trabajo de parto espontáneo, en las cuales se evaluó la realización de amniotomía vs no realización de amniotomía, no se observó diferencia significativa en la duración del primer periodo del trabajo de parto (Diferencias de medias -20.43 minutes, IC95% -95.93 a 55.06), realización de cesáreas (RR 1.27, IC95% 0.99 a 1.62), satisfacción materna (diferencia de media estandarizada 0.27, IC95% -0.49 a 1.04) y calificación Apgar menor de 7 a los 5 minutos (RR 0.57, IC95% 0.31 a 1.06).	**1+** **NICE** *Smyth RM, 2013*
R	No se recomienda realizar amniotomía rutinaria para abreviar el trabajo de parto.	**No recomendado** **GRADE** *WHO: intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018*
E	Los hallazgos de un ensayo clínico controlado aleatorizado (n=375 pacientes), en el que se comparó el uso rutinario de oxitocina versus la evolución espontánea durante el trabajo de parto, para evaluar el incremento en el riesgo de sangrado posparto, mostró que en el grupo de pacientes que emplearon oxitocina rutinaria durante el trabajo de parto presentaron significativamente mayor sangrado posparto en comparación con el grupo de pacientes con evolución espontánea (230.0 ± 99.3 vs 181 ± 81 ml, respectivamente; p = 0.001)	**2+** **NICE** *Mansy A, 2017*
R	No se recomienda el uso rutinario de oxitocina para abreviar el trabajo de parto.	**No recomendado** **GRADE** *WHO: intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018*
E	Una revisión sistemática Cochrane, en la que se incluyeron 21 ECA de baja calidad, con un total de 3,286 pacientes, evaluó el efecto de los antiespasmódicos versus placebo en el trabajo de parto en embarazos de término. Se observó que el uso de antiespasmódicos durante el primer periodo del trabajo de parto aumentó significativamente la	**2+** **NICE** *Rohwer AC, 2013*

E	Una revisión sistemática no Cochrane, que incluyó a treinta y siete estudios observacionales, con un total de 208,000 mujeres en trabajo de parto evaluó la duración de la fase activa y fase latente del trabajo de parto, así como el segundo periodo del mismo en mujeres con embarazo no complicado y evolución perinatal normal. Entre los principales hallazgos, se observó que en mujeres nuliparas, la duración media de la fase latente del trabajo de parto (antes de los 5 cm de dilatación) fue de 3.7-5.9 horas, la duración media de la fase activa del trabajo de parto (a partir de los 5 cm de dilatación) fue de 3.8-4.3 horas, mientras que la duración media del segundo periodo del trabajo de parto fue de 14 a 66 minutos.	**2++** **NICE** *Abalos E, 2018*
E	Evidencia procedente de una revisión sistemática no Cochrane, en la que se incluyeron 17 estudios observacionales, con más de 99,971 mujeres con trabajo de parto espontáneo de bajo riesgo, para evaluar el patrón de dilatación cervical, mostró que el tiempo promedio para avanzar 1 cm en las mujeres nulíparas fue superior a 1 hora hasta que se alcanzó una dilatación de 5 cm, con un progreso marcadamente rápido después de los 6 cm. Cabe destacar que una expectativa de un umbral mínimo de dilatación cervical de 1 cm / hora durante la primera etapa del parto no es realista para la mayoría de las mujeres nulíparas.	**2+** **NICE** *Oladapo OT, 2018*
E	Los hallazgos de un estudio mexicano observacional en el que se incluyeron 370 mujeres sanas, primigestas y con embarazo de término, mostró que la duración total del trabajo de parto fue de 862 minutos (14 horas y 12 minutos), a partir de los 4 centímetros de dilatación la duración promedio fue de 234 minutos (3 horas y 54 minutos).	**2+** **NICE** *Moreno-Santillán A, 2018*
R	Dada la gran variabilidad reportada en la tasa de dilatación durante el primer periodo de trabajo de parto, no se recomienda emplear el criterio de dilatación de 1cm/h como referencia para diagnosticar la de falta de progresión de trabajo de parto.	**No recomendado** **GRADE** *WHO: intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018*
✓	La duración del trabajo de parto es un evento extremadamente variable, por lo que no se sugiere realizar el diagnóstico de detención del trabajo de parto con base a la evaluación estricta del patrón de dilatación/tiempo. (ver cuadro 1)	**Punto de buena práctica**

	Puede valorarse la práctica de la episiotomía en casos de periné corto; presentación de cara, compuesta o de nalgas; así como ante la presencia de distocia de hombros o necesidad de parto instrumentado. Siempre deberá realizarse bajo analgesia adecuada, y la técnica recomendada es la mediolateral.	**Punto de buena práctica**
	Los hallazgos de una revisión sistemática Cochrane que incluyó 9 ECA y estudios cuasiexperimentales, con 3,948 mujeres, en la que se evaluó si la acción de presionar el fondo uterino en mujeres embarazadas con bajo riesgo versus no ejercer presión en el fondo del útero, es efectiva para lograr un parto vaginal espontáneo y prevenir una segunda etapa prolongada o la necesidad de un parto quirúrgico, así como para explorar los efectos adversos maternos y neonatales relacionados con la presión del fondo, concluyó que se observó mayor número de desgarros cervicales en el grupo de pacientes a las que se les realizó presión fúndica (RR 4.90; IC 95% 1.09-21.98, n=295). No se observaron diferencias significativas en las variables relacionadas con: parto instrumentado, cesárea, Apgar a los 5 minutos, pH bajo en cordón umbilical, muertes maternas o neonatales. Cabe destacar que la revisión sistemática señala importantes limitaciones metodológicas entre ellos: pobre tamaño de muestra, gran heterogeneidad entre los estudios y pobre generalización de los resultados.	**2+** **NICE** *Hofmeyr G, 2017*
	Para facilitar el nacimiento, no se recomienda aplicar presión en el fondo del útero durante el periodo expulsivo (maniobra de Kristeller).	**No recomendado** **GRADE** *WHO: intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018*

Documento de origen: gpc atención amigable del tdp.pdf

E	Evidencia de baja a moderada calidad sugiere que existen intervenciones efectivas en el tercer período del trabajo de parto para reducir la incidencia de hemorragia postparto grave y la necesidad de hemotransfusión, entre ellas el manejo activo en comparación con el manejo fisiológico y expectante.	**1+/2+** **NICE** *Masuzawa Y, 2018* *Begley CM, 2015*
E	Evidencia de baja calidad sugiere que el uso de oxitocina en unidades rurales en comparación con grupo control (no intervención o atención habitual/estándar) para el manejo del tercer período del trabajo de parto disminuye la incidencia de hemorragia posparto (> 500 ml) (RR 0.49, IC 95% 0.27 a 0.90; 1174 mujeres).	**2+** **NICE** *Pantoja T, 2016*

Imagen 16/23: gpc_atención_amigable_del_tdp.pdf-0027-01.png

E	En una revisión sistemática Cochrane, en la que se incluyeron tres ECA (con n= 199, 4058 y 23,616 mujeres respectivamente), en la que se evaluaron los efectos de la tracción controlada del cordón umbilical (TCCU) durante el tercer periodo del trabajo de parto, mediante. Mostró que la TCCU durante el tercer periodo del trabajo de parto, se asoció con una disminución de la perdida sanguínea ≥ 500 ml (RR 0.93, IC95% 0.88 a 0.99), menor duración del tercer periodo y menor necesidad de extracción manual de la placenta (RR 0.69, IC95% 0.57 a 0.83).	**1+** **NICE** *Hofmeyr GJ, 2015*
E	Evidencia de un estudio observacional retrospectivo muestra que los principales factores asociados a endometritis posparto fueron: revisión manual de cavidad uterina (OR 10.5; IC 95% 3.7-36.4), hemorragia posparto (OR 7.2; IC 95% 2.5-25.6) y duración del trabajo de parto (OR 1.07; IC 95% 1.07 – 1.19).	**2+** **NICE** *Henderson K, 2015*
✓	No se aconseja realizar revisión manual de cavidad uterina rutinaria, pues puede predisponer a endometritis.	**Punto de buena práctica**
E	En una revisión sistemática Cochrane, en el que se incluyó un ECA y dos estudios cuasiexperimentales, con una población de 1,779 mujeres, para evaluar sí la administración rutinaria de antibióticos profilácticos a mujeres después del parto vaginal normal (sin complicaciones) en comparación con placebo o sin profilaxis con antibióticos, reduce las morbilidades infecciosas maternas después del parto y mejora los desenlaces, concluyó que existió poca o ninguna diferencia entre los grupos para el riesgo de infección del tracto urinario (RR 0,25; IC95%: 0,05 a 1,19; dos ensayos, 1,706 mujeres, evidencia de baja calidad), infección de la herida después de episiotomía (RR 0,78, IC95%: 0,31 a 1,96, dos ensayos, 1,364 mujeres, evidencia de calidad muy baja) y duración de la estancia hospitalaria materna en días (DM -0,15, IC95%: -0,31 a 0,01, un ensayo, 1,291 mujeres, evidencia de muy bajo calidad). Por otra parte, se mostró disminución del riesgo de endometritis (RR 0.28, IC 95% 0.09 – 0.83, dos ensayos, 1,364 mujeres, evidencia de baja calidad).	**2+** **NICE** *Bonet M, 2017*
R	No se recomienda administrar antibiótico profiláctico en mujeres después de un parto sin complicaciones.	**No recomendado** **GRADE** *WHO: intrapartum care for a positive childbirth experience,*

R	Se recomienda la analgesia epidural para el alivio del dolor en mujeres sanas que así lo soliciten, más no debe de ofrecerse de manera rutinaria.	**Recomendado** **GRADE** *WHO: intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018*
E	Los hallazgos de una revisión sistemática Cochrane en la que se incluyeron nueve ECA con un total de 15,752 mujeres en trabajo de parto, para evaluar la efectividad y seguridad del inicio temprano de la analgesia epidural en comparación al inicio tardío, concluyó que no se observaron diferencias significativas en los grupos de estudio respecto al riesgo de cesáreas (RR 1.02; IC95% 0.96 a 1.08, nueve, 15,499 mujeres, evidencia de alta calidad, parto instrumentado (RR 0.93; IC95% 0.86 a 1.01, ocho estudios, 15,379 mujeres, evidencia de alta calidad), duración del segundo periodo del trabajo de parto (Diferencia de medias -3.22 minutes; IC95% -6.71 a 0.27, ocho estudios, 14,982 mujeres, evidencia de alta calidad y en la calificación de Apgar (RR 0.96; IC95% 0.69 a 1.33, siete estudios, 14,924 mujeres).	**1+** **NICE** *Sng BL, 2014*
R	Se recomienda administrar la anestesia regional en el momento en que la mujer en trabajo de parto lo solicite, aún durante la fase latente.	**Recomendado** **GRADE** *National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guidelines. Intrapartum Care, 2014*
✓	Siempre que se cuente con la posibilidad, la analgesia epidural deberá proporcionarse a la mujer en trabajo de parto en el momento en que lo solicite, sin importar la dilatación cervical que cuente, procurando emplear la menor dosis posible de anestésico (ver cuadro 2) y monitorizando la frecuencia cardiaca fetal después de su administración.	**Punto de buena práctica**
E	Los hallazgos de una revisión sistemática Cochrane, en la que se incluyeron 19 ECA y cuasiexperimentales para comparar los métodos de relajación con la atención estándar, ningún tratamiento u otras formas no farmacológicas para el alivio del dolor durante el trabajo de parto, en una población de 2,519 mujeres, mostró que el empleo de técnicas de relajación en comparación con los cuidados estándar, disminuyeron la intensidad del dolor durante la fase lantente del trabajo de parto (MD -1.25; IC 95% -1.97 a 0.53). Por otra parte, evidencia de muy baja calidad mostró que las mujeres que recibieron	**2++** **NICE** *Smith CA, 2018*

Documento de origen: gpc atención amigable del tdp.pdf

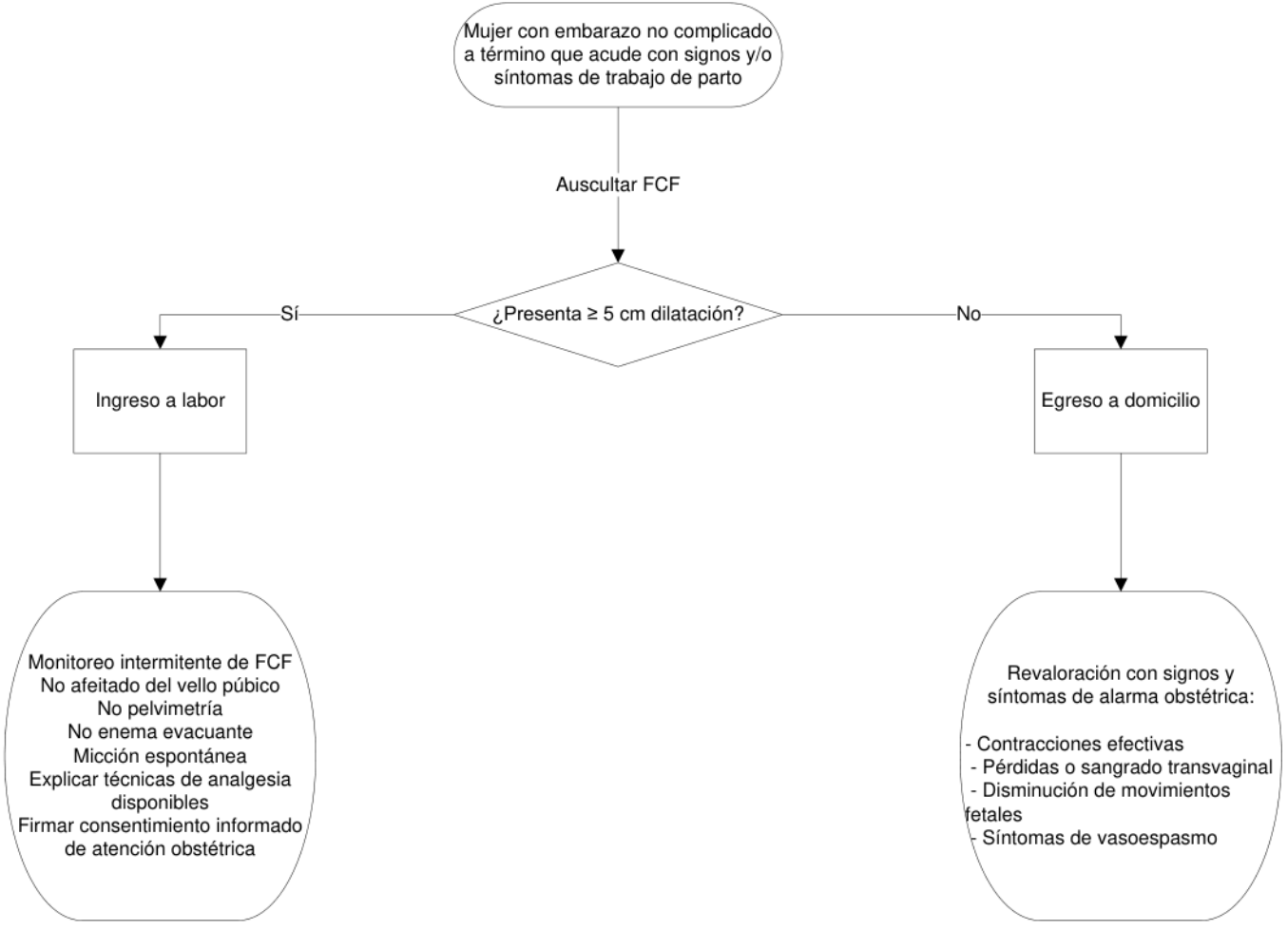


Imagen 19/23: gpc_atención_amigable_del_tdp.pdf-0034-06.png

Documento de origen: gpc atención amigable del tdp.pdf

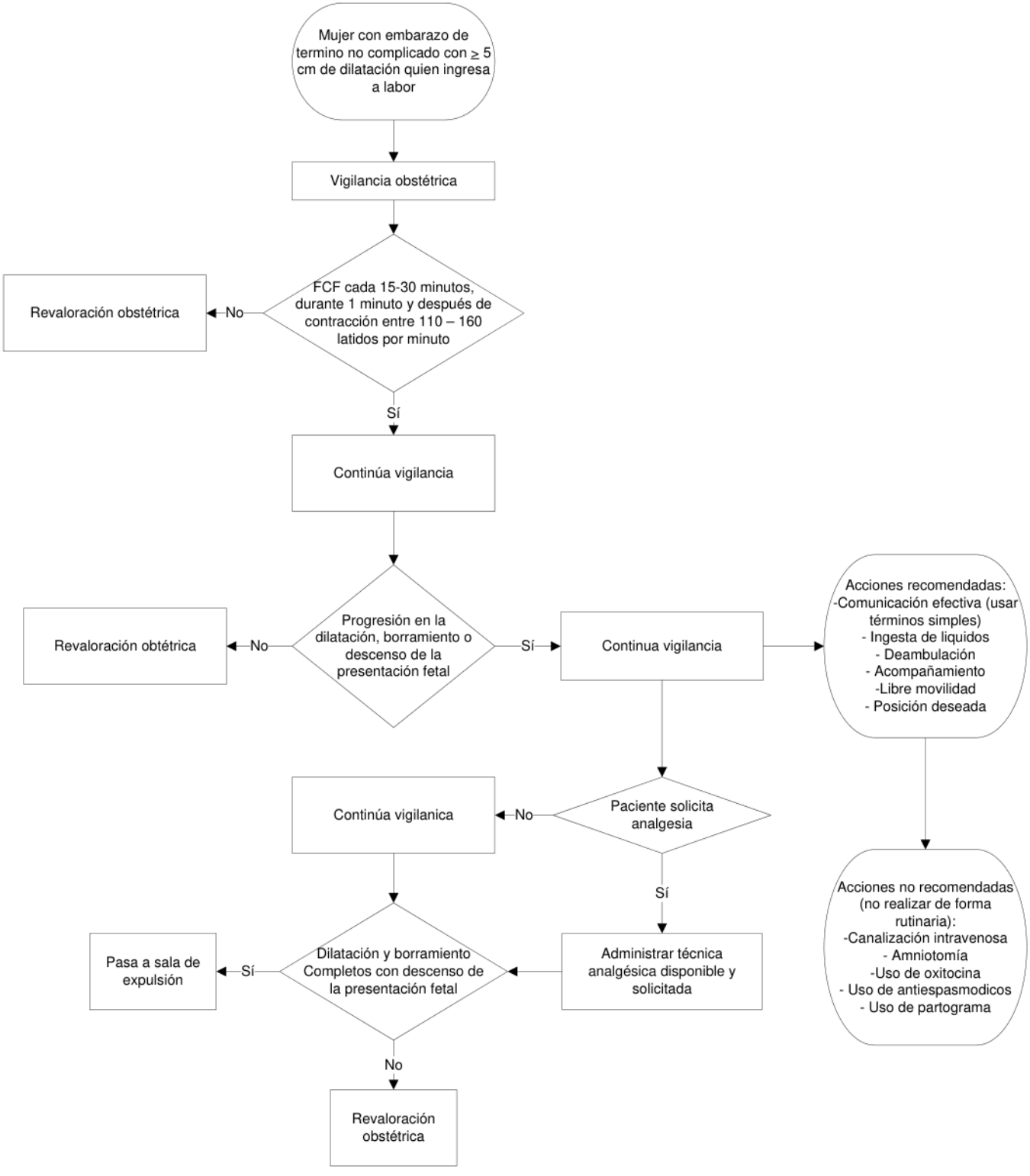


Imagen 20/23: gpc_atención_amigable_del_tdp.pdf-0035-02.png

Documento de origen: gpc atención amigable del tdp.pdf

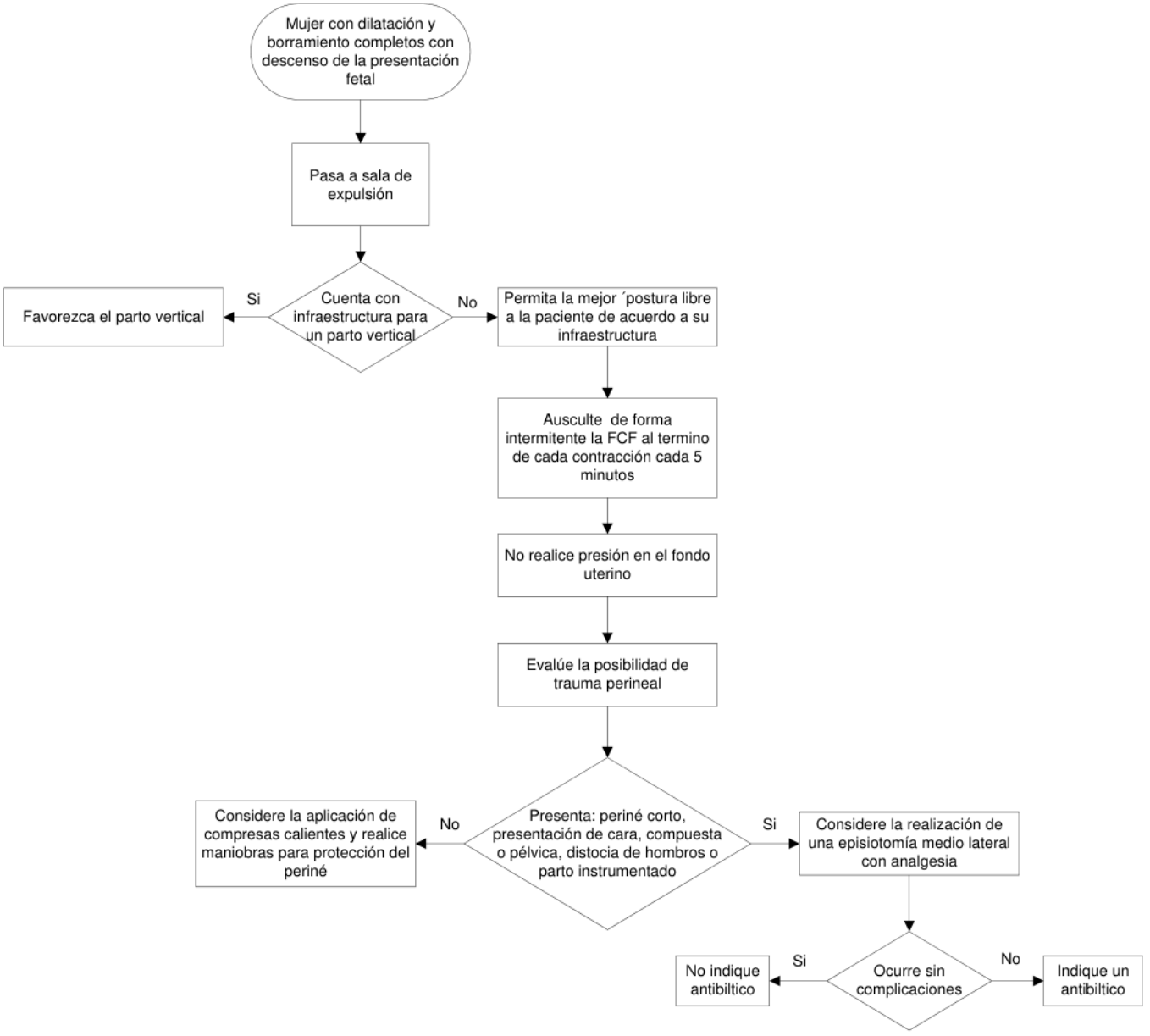
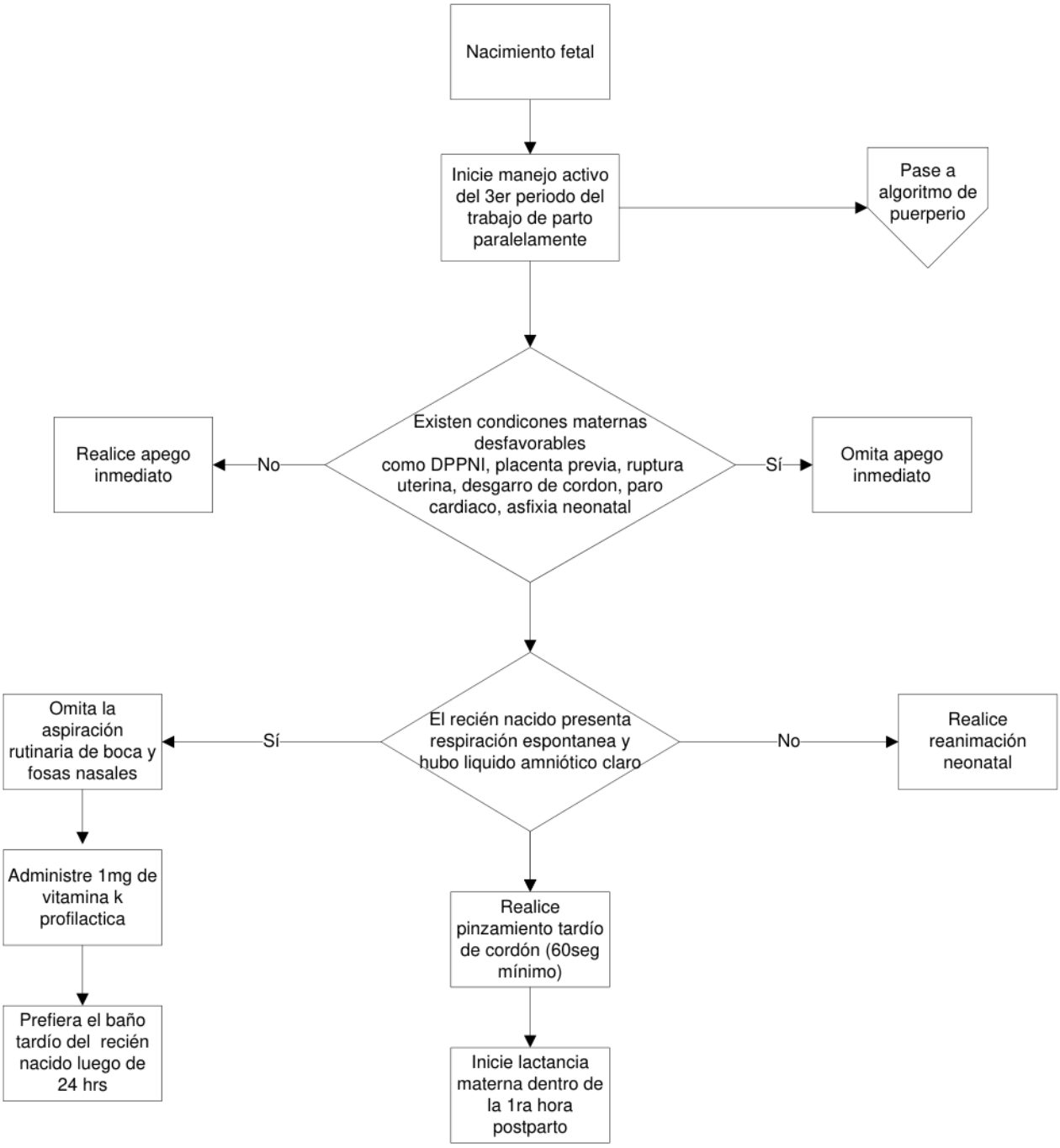


Imagen 21/23: gpc_atención_amigable_del_tdp.pdf-0036-02.png


Nacimiento fetal
Inicie manejo activo del 3er periodo del trabajo de parto paralelamente
Pase a algoritmo de puerperio
Existen condicones maternas desfavorables como DPPNI, placenta previa, ruptura uterina, desgarro de cordon, paro cardiaco, asfixia neonatal
No
Realice apego inmediato
Sí
Omita apego inmediato
El recién nacido presenta respiración espontanea y hubo liquido amniótico claro
Sí
Omita la aspiración rutinaria de boca y fosas nasales
Administre 1mg de vitamina k profilactica
Prefiera el baño tardío del recién nacido luego de 24 hrs
No
Realice reanimación neonatal
Realice pinzamiento tardío de cordón (60seg mínimo)
Inicie lactancia materna dentro de la 1ra hora postparto

Documento de origen: gpc atención amigable del tdp.pdf

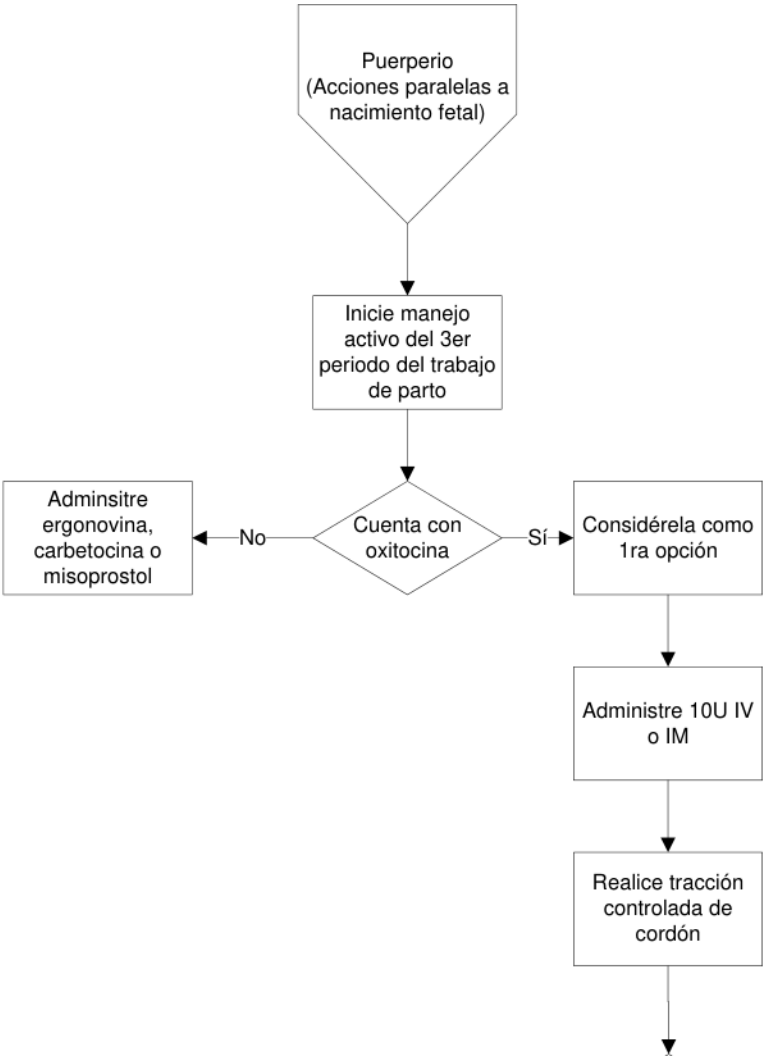


Imagen 23/23: gpc_atención_amigable_del_tdp.pdf-0038-02.png